PERFIL DE SALUD LOCAL · ATARFE (GRANADA) · INE 18022

La salud de Atarfe

Un municipio metropolitano que crece, una población joven y una ciudadanía que respondió a la pregunta de cómo se siente.

BORRADOR PARA VALIDACIÓN TÉCNICA · 9 DE NOVIEMBRE DE 2026

20.952
habitantes en 2025 (padrón, INE)

+16,4 %
crecimiento de la población entre 2014 y 2024

13,4 %
de la población tiene 65 años o más (2025)

910
respuestas al Monitor de bienestar socioemocional (2026)

RESUMEN

La mortalidad y la enfermedad crónica siguen el patrón de la provincia: enfermedades circulatorias y tumores como primeras causas de muerte, dislipemia e hipertensión como diagnósticos más frecuentes. Atarfe registra más asma, trastorno de ansiedad, obesidad y litiasis urinaria que Granada.

DESIGUALDADES

El trastorno de ansiedad registrado duplica en las mujeres el de los hombres. En el Monitor, las mujeres y las personas de 25 a 64 años puntúan más bajo. No hay datos de renta por sección censal en el expediente.

COMUNIDAD

El Ayuntamiento y el Distrito Sanitario reunieron 910 respuestas en institutos y otros espacios del municipio. Constan 17 recursos de Atarfe en Localiza Salud; su validación como activos no está declarada.

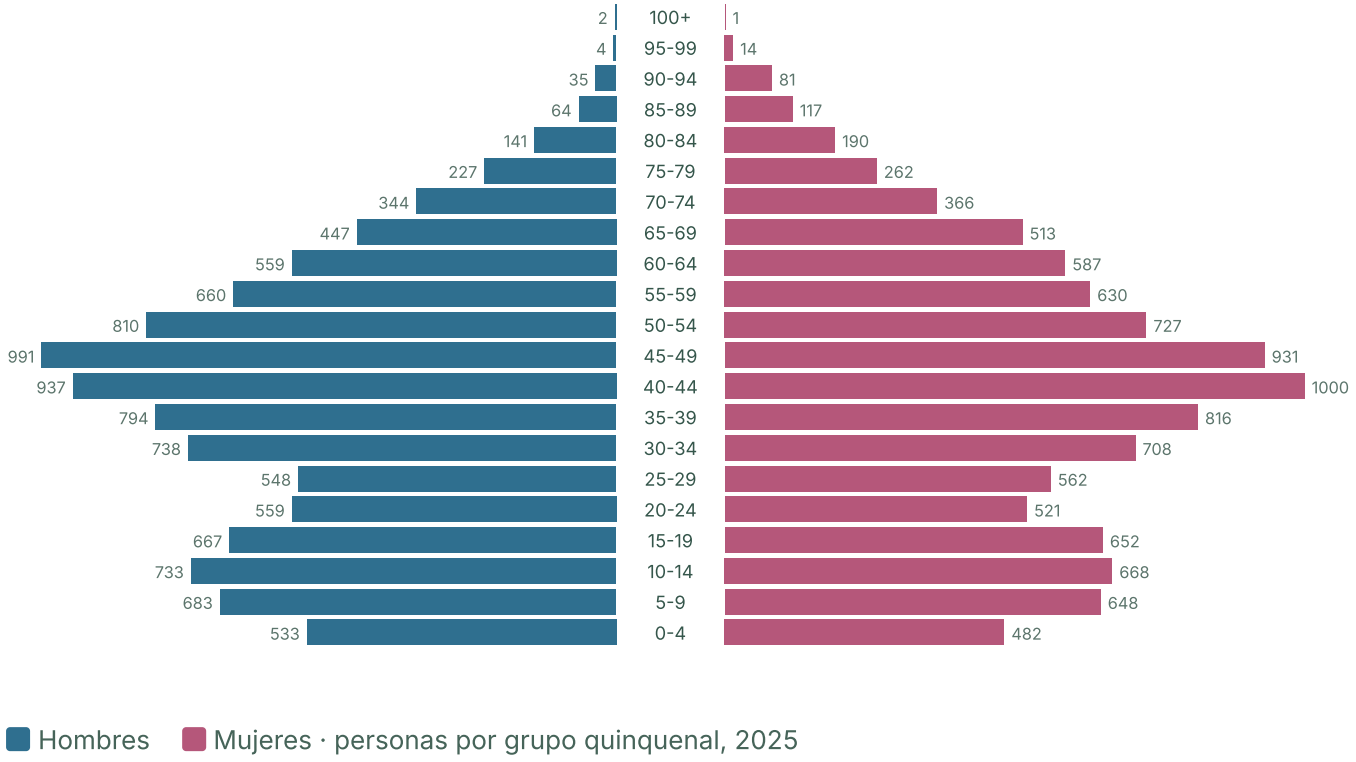
SALUD

El factor más bajo del bienestar socioemocional es el control (energía y tranquilidad): la mitad de quienes respondieron se sintió tranquila solo en algún momento o en ninguno durante la última semana.

Fuentes: INE, Padrón municipal 2025 (tabla 68535); Informe de la situación de salud en el municipio de Atarfe, Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, 21/11/2025; Monitor de bienestar socioemocional Atarfe 2026 (REDCap, export del 05/11/2026); Localiza Salud, tabla de recursos aportada el 05/11/2026.

QUIÉN VIVE AQUÍ

Una población joven, en crecimiento y diversa



Indicador	Atarfe	Año y fuente
Población total	20.952	2025 · INE, Padrón (tabla 68535)
Población total	20.492	2024 · Informe de Salud, tabla 1
Hombres / mujeres	10.476 / 10.476	2025 · INE, Padrón
Menores de 15 años	3.747 (17,9 %)	2025 · INE, Padrón
65 años o más	2.808 (13,4 %)	2025 · INE, Padrón
Edad media	39 años	2024 · Informe de Salud, tabla 1
Crecimiento de la población	+16,4 %	2014–2024 · Informe de Salud
Nacimientos / defunciones	189 / 109	2023 · Informe de Salud
Inmigraciones / emigraciones	1.358 / 1.051	2023 · Informe de Salud
Marruecos entre la población extranjera	31,3 %	Informe de Salud, introducción
Población en agrupaciones urbanas	94,3 %	2024 · IECA/BADEA, consulta 19824 («zona de densidad intermedia»)
Renta, hogares y empleo	No consta	Pendiente de incorporar (IECA, INE)

No se dispone en el expediente de la pirámide de Andalucía de 2025 para compararla: la pirámide se muestra sin comparador. Las cifras de 2024 (Informe) y 2025 (Padrón) son de años distintos y no se mezclan.

PANEL DE SALUD

Indicadores con sus comparadores

Los valores se reproducen tal como los publica cada fuente. Sin intervalos de confianza publicados, el panel no marca «mejor» ni «peor».

Morbilidad crónica registrada · casos por 10.000 habitantes · 2024

Diagnóstico	Atarfe	Granada	Atarfe mujeres	Atarfe hombres
Dislipemia	2.332,12	2.656,45	2.422,55	2.240,79
Hipertensión	1.952,16	2.289,39	1.984,80	1.919,19
Artrosis, espondilosis	1.830,76	2.009,28	2.256,76	1.400,47
Asma	1.508,96	1.402,49	1.558,46	1.458,95
Trastorno de ansiedad	1.126,49	1.030,68	1.522,92	726,08
Diabetes	865,12	898,39	764,28	966,98
Hipotiroidismo	771,77	917,89	1.265,22	273,36
Obesidad	599,99	553,83	668,14	531,16
Dependencia del tabaco	576,74	611,13	538,92	614,94
Litiasis urinaria	390,17	356,51	432,24	347,69

Fuente: Informe de Salud de Atarfe (21/11/2025), tabla 6.

Mortalidad y cáncer

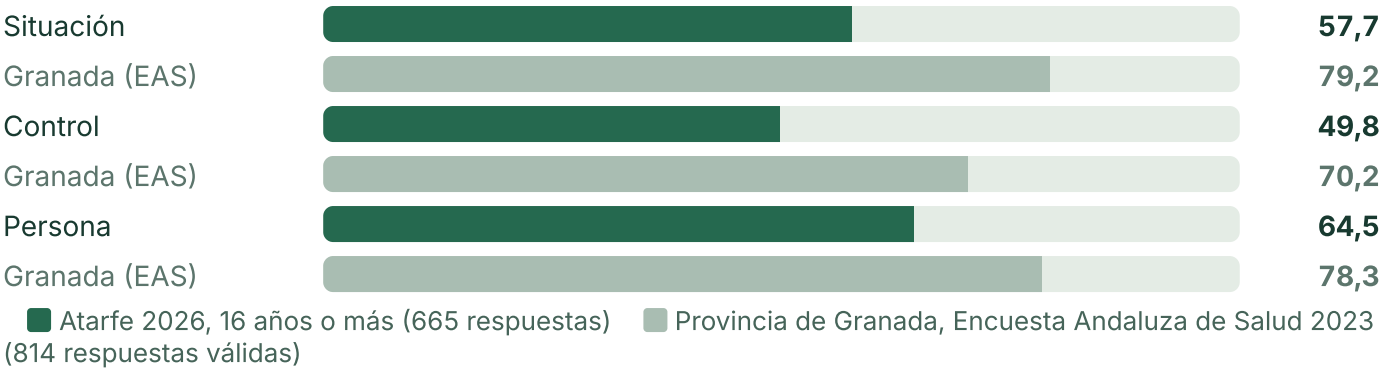
Indicador	Atarfe	Periodo y fuente
Defunciones totales	113 → 109	2022 → 2023 · Informe, tabla 3
Enfermedades del sistema circulatorio	38 → 27	2022 → 2023 · Informe, tabla 3
Tumores	27 → 24	2022 → 2023 · Informe, tabla 3
Enfermedades del sistema respiratorio	11 → 15	2022 → 2023 · Informe, tabla 3
Casos de cáncer	457	2015–2019 · Informe, discusión
Incidencia de cáncer, tasa estandarizada / bruta (por 100.000)	718,6 / 499,3	2015–2019 · Informe, discusión

Prevención y vigilancia

Indicador	Atarfe	Distrito	Andalucía	Periodo
Cribado de cáncer de mama: participación sobre invitadas	80,57 %	—	—	Informe, tabla 11
Cribado de cáncer de mama: participación sobre población elegible	58,70 %	—	—	Informe, tabla 11
Cribado de cáncer de colon: participación sobre población elegible	42,97 %	—	—	Informe, tabla 12
Vacunación infantil: primovacunación	98,54 %	—	—	2024 · Informe, tabla 10
Infecciones de transmisión sexual (por 100.000)	151,28	292,09	175,10	2024 · Informe, tabla 9
Tosferina, casos declarados	37	—	—	2024–2025 · Informe, tabla 7

Bienestar socioemocional (IBSE) · escala 0–100





> La referencia de Granada es «no local» y procede de una encuesta con entrevista en el hogar y muestra probabilística; el Monitor de Atarfe se respondió en papel o por QR, con muestra voluntaria. La diferencia entre las dos barras no puede leerse como diferencia de bienestar sin separar el efecto del modo de respuesta.

Fuentes: Monitor de bienestar socioemocional Atarfe 2026; Encuesta Andaluza de Salud 2023, submuestra de Granada (cálculo propio desde microdatos, fixture de COMPÁS). Ambas en escala común 0–100 (ver anexo, A.3).

DESIGUALDAD

Lo que la media del municipio no muestra

Por sexo y edad · IBSE total, escala 0–100

Grupo de edad	Hombres	Mujeres	Diferencia	Respuestas (H / M)
13–15	69,9	65,2	-4,7	72 / 73
16–24	68,0	59,0	-9,0	62 / 67
25–44	61,4	58,6	-2,8	56 / 120
45–64	57,8	60,4	+2,6	77 / 139
65+	65,1	62,9	-2,2	27 / 117
Total	**64,3**	**61,0**	**-3,3**	294 / 517

Monitor Atarfe 2026, 810 respuestas válidas con edad asignable. Medias de la muestra participante; los grupos con menos de 30 respuestas se leen con especial cautela (hombres de 65 o más: 27).

Por sexo · registros sanitarios

El trastorno de ansiedad registrado alcanza 1.522,92 casos por 10.000 mujeres frente a 726,08 por 10.000 hombres; el hipotiroidismo, 1.265,22 frente a 273,36. Los hombres concentran más casos de cardiopatía isquémica (275 frente a 101), EPOC (501 frente a 305) y diabetes (928 frente a 742).

Informe de Salud de Atarfe, tablas 4, 5 y 6.

Por territorio

El expediente no contiene datos de renta, empleo ni salud por sección censal. No es posible describir diferencias internas entre barrios o zonas del municipio. Que no se observen no significa que no existan.

Fuente prevista: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares 2024, por sección censal (CUSEC).

1 · PUNTO DE PARTIDA

De qué se parte

Atarfe tenía 20.952 habitantes en 2025 según el padrón del INE. El Pleno aprobó la adhesión a la Red Local de Acción en Salud el 28 de noviembre de 2024, el Ayuntamiento firmó el formulario de adhesión en marzo de 2025 y el Grupo Motor está constituido. El 27 de febrero de 2026 se celebró el taller de impulso, con el Ayuntamiento, el centro de salud, los servicios de salud mental comunitaria, asociaciones y ciudadanía. Una reunión posterior presentó los resultados del Monitor de bienestar socioemocional. No hay actas de esas reuniones.

Este Perfil cruza tres fuentes:

Fuente	Fecha y escala	Qué aporta
Informe de la situación de salud en el municipio de Atarfe (Carlos del Moral Campaña y María José Molina Rueda, Epidemiología, Distrito Granada-Metropolitano)	21/11/2025 · municipal, con comparadores provinciales, de Distrito y de Andalucía	Demografía, mortalidad, morbilidad crónica, cáncer, vigilancia, vacunación y cribados (fuente primaria)
Monitor de bienestar socioemocional Atarfe 2026 (IBSE, Bericat 2014), Ayuntamiento de Atarfe y Distrito Sanitario Granada-Metropolitano	6/03–26/04/2026 · municipal, 910 respuestas, 811 válidas, de 13 a 88 años	Bienestar socioemocional en cuatro factores (estudio complementario)
Localiza Salud, Ministerio de Sanidad	Tabla de 05/11/2026 · municipal, 17 fichas	Recursos comunitarios registrados (capacidades)

Se usan además como contexto el padrón del INE de 2025 y la consulta 19824 de BADEA/IECA (grado de urbanización, 2024), y como referencia no local la submuestra de Granada de la Encuesta Andaluza de Salud de 2023 para el IBSE.

Lo que no consta. Renta, hogares, nivel educativo y empleo del municipio y de sus secciones censales; priorización ciudadana; actas del Grupo Motor; validación de los recursos de Localiza Salud como activos para la salud; datos de salud de periodos anteriores medidos de la misma manera. Es el primer ciclo diagnóstico de Atarfe en la Red: no hay referente temporal propio.

> **Corrección del IBSE.** Las fórmulas del proyecto REDCap del Monitor no dejaban los cuatro factores en la misma escala: Vínculo solo podía llegar a 75 y Situación y Control empezaban en 25. Los valores de este Perfil se han recalculado desde las ocho preguntas en una escala común de 0 a 100. El cambio no afecta a las respuestas ni a quién respondió, pero sí al orden de los factores: el más bajo es Control, no Vínculo. Detalle en el anexo, A.3.

2 · CONCLUSIONES

Lo que muestra el diagnóstico

Lectura de conjunto. El Informe de Salud describe un municipio cuya carga de enfermedad sigue el patrón provincial y que, por su juventud, no muestra todavía el peso del envejecimiento. Lo que distingue a Atarfe en los registros sanitarios son cuatro diagnósticos con prevalencia superior a la de Granada (asma, trastorno de ansiedad, obesidad y litiasis urinaria) y una distribución muy desigual por sexo del trastorno de ansiedad. El Monitor de bienestar, una fuente independiente y construida de otra manera, apunta en la misma dirección: el componente más bajo del bienestar es el que recoge la energía y la tranquilidad, y puntúan más bajo las mujeres y las personas en edad de trabajar. Esa coincidencia entre fuentes es el hallazgo central del Perfil, y es una coexistencia observada, no una explicación de sus causas.

Frente a esa lectura de malestar, el diagnóstico encuentra capacidades: relaciones personales que la mayoría valora bien, una respuesta ciudadana de 910 personas a una encuesta voluntaria y 17 recursos comunitarios registrados. Faltan, en cambio, los datos que permitirían relacionar la salud con las condiciones de vida del municipio y de sus barrios.

C1. Atarfe es un municipio joven y en crecimiento, y no hay datos que muestren cómo se reparten dentro de él las condiciones de vida.

La población creció un 16,4 % entre 2014 y 2024, con una edad media de 39 años y un 13,1 % de mayores de 65 (Informe, tabla 1); en 2025, el 13,4 % según el padrón. El saldo migratorio fue positivo en 2023 (1.358 inmigraciones y 1.051 emigraciones) y Marruecos es el primer país de procedencia de la población extranjera (31,3 %). El 94,3 % de la población vive en agrupaciones urbanas (BADEA 2024). Es la estructura de un municipio metropolitano que recibe población. El expediente no permite saber cómo se distribuyen la renta, el empleo o la vivienda entre zonas, ni si la población que llega se concentra en alguna de ellas.

Lleva a R1.

C2. La enfermedad crónica sigue el patrón provincial, con más asma, trastorno de ansiedad, obesidad y litiasis urinaria que en Granada.

Las primeras causas de muerte en 2023 fueron las enfermedades circulatorias (27) y los tumores (24), como en la provincia y en Andalucía; las respiratorias pasaron de 11 a 15 defunciones entre 2022 y 2023 (Informe, tablas 2 y 3). La dislipemia (2.332,12 por 10.000) y la hipertensión (1.952,16) son los diagnósticos más frecuentes, con valores inferiores a los de Granada. Son superiores a Granada el asma (1.508,96 frente a 1.402,49), el trastorno de ansiedad (1.126,49 frente a 1.030,68), la obesidad (599,99 frente a 553,83) y la litiasis urinaria (390,17 frente a 356,51) (Informe, tabla 6).

Lleva a R2 y R3.

C3. Dos fuentes independientes coinciden en señalar el malestar emocional, y en ambas pesa más en las mujeres.

El trastorno de ansiedad registrado es más prevalente en Atarfe que en Granada y, dentro del municipio, duplica en las mujeres (1.522,92 por 10.000) el valor de los hombres (726,08) (Informe, tabla 6). En el Monitor, el factor Control, que reúne la energía y la tranquilidad, es el más bajo de los cuatro (51,1 sobre 100): el 50,7 % se sintió tranquilo solo en algún momento o en ninguno durante la última semana, y el 46,1 % rebosante de energía solo en algún momento o en ninguno. Las mujeres puntúan por debajo de los hombres en el índice total (61,0 frente a 64,3) y en Control (49,0 frente a 54,8). Es una coexistencia observada en el territorio, en el mismo ciclo; no demuestra que una cosa explique la otra.

Lleva a R4 y R5.

C4. El bienestar más bajo está en la edad de trabajar, y la brecha entre mujeres y hombres se abre en la juventud.

El índice total es de 67,6 entre los 13 y los 15 años, baja a 63,3 entre los 16 y los 24 y se queda en 59,5 entre los 25 y los 64, donde Control cae a 45,5 (25–44) y 47,4 (45–64). Entre los 16 y los 24 años los hombres puntúan 68,0 y las mujeres 59,0; entre los 13 y los 15 la diferencia es menor (69,9 frente a 65,2). Las personas de 25 a 64 años son, además, las que menos respondieron en proporción a su peso en el padrón, sobre todo los hombres.

Lleva a R5 y R6.

C5. Las relaciones sostienen el bienestar de la mayoría, pero una de cada cinco personas se sintió sola buena parte del tiempo.

Vínculo es el factor más alto (72,4) y apenas varía con la edad. Aun así, el 18,4 % se sintió solo buena parte del tiempo o casi siempre durante la última semana, y el 16,2 % deprimido. Entre las personas de 65 o más años, el 11,1 % no se sintió feliz en ningún momento o casi en ninguno y otro 11,1 % no disfrutó de la vida en ningún momento, frente a menos del 5 % entre los 13 y los 44 años.

Lleva a R5 y R7.

C6. La participación en el Monitor es en sí misma una capacidad del municipio, y su muestra no reproduce la población.

El Ayuntamiento y el Distrito Sanitario reunieron 910 respuestas, en papel y por QR, en institutos y otros espacios, entre marzo y abril de 2026. Para la población de 15 o más años (17.205 personas), una muestra aleatoria de 376 habría bastado como referencia; se reunieron 752 respuestas válidas de ese tramo de edad. La muestra no es aleatoria y su composición se aparta del padrón: las mujeres son el 64,8 % (50,4 % en el padrón), las personas de 15 a 24 años el 28,7 % (13,9 %) y los hombres de 65 o más el 3,6 % (7,3 %). Reponderar por edad y sexo apenas cambia el índice total (61,2 frente a 62,0 observado), pero no corrige quién eligió responder.

Lleva a R6.

C7. Los recursos registrados para el bienestar emocional son sobre todo sanitarios, y los comunitarios se dirigen a mayores y jóvenes.

De las 17 fichas de Localiza Salud, tres son grupos o talleres del centro de salud dirigidos al malestar emocional y al sueño (GRAFA, GRUSE y Taller de sueño saludable). Los recursos comunitarios se orientan a personas mayores (Centro de Participación Activa y sus talleres de coro, senderismo y gimnasia mental) o a adolescentes y jóvenes (Espacio Joven), con equipamientos de uso general (biblioteca, Centro Cívico, piscina cubierta, Punto Vuela, radio municipal, escuela y talleres artísticos, educación de personas adultas). No consta ningún recurso registrado dirigido específicamente a la población de 25 a 64 años, la del bienestar más bajo: es una laguna del mapa, no la prueba de que no existan. La validación de estas fichas como activos para la salud no está declarada, y el Centro de Participación Activa figura dos veces (61419 y 61585).

Lleva a R7 y R8.

C8. La prevención alcanza a casi toda la infancia y a la mayoría de las mujeres invitadas al cribado de mama, y a menos de la mitad de la población elegible para el de colon.

La cobertura vacunal supera el 96 % en todos los indicadores (Informe, tabla 10). En el cribado de cáncer de mama participa el 80,57 % de las mujeres invitadas (58,70 % de la población elegible); en el de colon, el 42,97 % de la población elegible (Informe, tablas 11 y 12).

Lleva a R3.

3 · CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS

Dónde coinciden las fuentes y dónde no

Convergencia: malestar emocional y diferencia por sexo

El Informe (trastorno de ansiedad registrado, 2024) y el Monitor (factor Control, 2026) coinciden en señalar el malestar emocional y en situarlo más en las mujeres. Las dos fuentes miden cosas distintas: una cuenta diagnósticos en la historia clínica de quien consulta; la otra recoge cómo se sintió durante una semana quien quiso responder. Que apunten en la misma dirección aumenta la solidez de la lectura; no la convierte en una medida de prevalencia.

Divergencia: Atarfe frente a la Encuesta Andaluza de Salud

Las personas de 16 o más años que respondieron en Atarfe puntúan 61,1 en el IBSE; la submuestra de Granada de la Encuesta Andaluza de Salud de 2023, 78,4. La diferencia es grande y en los cuatro factores. Puede reflejar diferencias reales, pero también el modo de respuesta (cuestionario autoadministrado frente a entrevista personal), la selección de quien responde y los tres años que separan las dos mediciones. Con la información disponible no puede atribuirse a ninguna de esas causas.

Cuestión sin contraste: mortalidad respiratoria y asma

Las defunciones por enfermedades respiratorias pasaron de 11 a 15 entre 2022 y 2023 y el asma registrada supera el valor provincial. Ninguna otra fuente del expediente trata la salud respiratoria ni el entorno.

4 · LO QUE NO SABEMOS

Lagunas que condicionan las conclusiones

Laguna	Condiciona	Dato que la cerraría
L1. Renta, empleo, nivel educativo y vivienda del municipio y por sección censal	C1, C3, C4	INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares 2024 (tablas por sección); IECA, SIMA (paro registrado, contratos, IRPF)
L2. Bienestar emocional de la población medido con muestra probabilística y el mismo modo de respuesta que la referencia	C3, C6	Monitor con diccionario corregido, selección aleatoria o cuotas por edad y sexo, y comparación con la EAS por modo de administración
L3. Experiencia de la población de 25 a 64 años, sobre todo de los hombres	C4, C6	Respuestas de ese tramo en centros de trabajo, AMPA, asociaciones; material cualitativo del Grupo Motor
L4. Estado de validación de los 17 recursos de Localiza Salud y recursos no registrados	C7	Validación conforme a los criterios de la Junta de Andalucía; revisión del posible duplicado del Centro de Participación Activa; mapeo participativo
L5. Prioridades de la ciudadanía	C3–C7	Priorización temática o por líneas estratégicas del Grupo Motor y de la ciudadanía
L6. Barreras de participación en el cribado de cáncer de colon	C8	Información del centro de salud y del programa de cribado

5 · RECOMENDACIONES DEL PERFIL

Qué conviene conocer, contrastar y abordar

Propuestas redactadas por el equipo técnico. Ninguna nace elegida: el equipo técnico elige o descarta cada una antes de la versión institucional. No están ordenadas entre sí ni asignan responsables, plazos, recursos o indicadores.

CONOCER

R1. Incorporar al expediente la renta por sección censal y los indicadores de empleo del municipio, para describir dónde se concentran las condiciones de vida más desfavorables. Deriva de C1 y L1. Habilita: leer las desigualdades internas antes de priorizar.

CONTRASTAR

R2. Contrastar con el centro de salud y con Epidemiología qué hay detrás de la mayor prevalencia registrada de asma, obesidad y litiasis urinaria y del aumento de la mortalidad respiratoria. Deriva de C2. Habilita: decidir si alguno de estos problemas entra en la priorización.

CONTRASTAR

R3. Contrastar con el centro de salud las barreras de participación en el cribado de cáncer de colon. Deriva de C8 y L6.

CONTRASTAR

R4. Contrastar con el Grupo Motor y con los servicios de salud mental comunitaria la lectura conjunta de la ansiedad registrada y del factor Control, y en qué grupos de población la reconocen. Deriva de C3. Habilita: dar por buena o matizar la convergencia.

ABORDAR

R5. Abordar el bienestar emocional y la salud mental como área de trabajo del Plan, atendiendo a las mujeres y a las personas en edad de trabajar. Deriva de C3, C4 y C5 · relación de grado 1, observada en el territorio. Habilita: que el Grupo Motor decida si la incluye entre sus líneas.

CONOCER

R6. Repetir el Monitor con el diccionario corregido y con un procedimiento que alcance a las personas de 25 a 64 años y a los hombres mayores, y separar el efecto del modo de respuesta antes de comparar con la Encuesta Andaluza de Salud. Deriva de C4, C6, L2 y L3.

ABORDAR

R7. Abordar la soledad no deseada y la pérdida de disfrute en las personas mayores desde los recursos que ya se dirigen a ellas. Deriva de C5 y C7 · relación de grado 1. Habilita: que el Grupo Motor la valore dentro o fuera del área de bienestar emocional.

CONOCER

R8. Validar como activos los recursos de Localiza Salud que cumplan los criterios, resolver el posible duplicado y mapear con la comunidad los recursos para la población adulta en edad de trabajar. Deriva de C7 y L4.

6 · PASO AL PLAN DE ACCIÓN

Frontera de decisión

El Perfil termina aquí. El Plan de Acción recibe las conclusiones, las recomendaciones y las lagunas que el equipo técnico elija. Priorizar entre necesidades corresponde al Grupo Motor; las líneas estratégicas, los objetivos y los indicadores del Plan se definen después de esa priorización y deben poder derivarse de una conclusión o de una recomendación de este Perfil.

7 · AUTORÍA Y VALIDACIÓN

Responsabilidad técnica

Responsable técnico	Blas Ramón Hermoso Rico, técnico de educación para la salud y participación comunitaria, Distrito Sanitario Granada-Metropolitano
Estado	Borrador para validación técnica. Conclusiones y recomendaciones pendientes de elección.
Fecha del borrador	9 de noviembre de 2026
Compilado desde el expediente	Cifras del Informe de Salud, del padrón 2025, de BADEA, del Monitor IBSE y de Localiza Salud (anexo)
Redactado por el equipo técnico	Lectura de conjunto, conclusiones C1–C8, convergencias, lagunas y recomendaciones R1–R8
Validación	Pendiente

ANEXO COMPILADO

Evidencia, cálculos y trazabilidad

A.1 Tabla de trazabilidad de las conclusiones

Conclusión	Tipo	Evidencias principales	Relación	Límite principal	Rec.
C1	Hecho	Informe, tabla 1 e introducción; INE 2025; BADEA 19824	Sin relación declarada	Sin datos socioeconómicos ni por sección	R1
C2	Hecho	Informe, tablas 2, 3 y 6	Sin relación declarada	Comparación sin intervalos publicados	R2, R3
C3	Interpretación	Informe, tabla 6; Monitor IBSE 2026, factor Control e ítems	Grado 1 · coexistencia observada	Muestra no probabilística; medidas distintas	R4, R5
C4	Hecho	Monitor IBSE 2026 por edad y sexo	Sin relación declarada	Grupos pequeños; menor respuesta de 25–64	R5, R6
C5	Hecho	Monitor IBSE 2026, Vínculo e ítems por edad	Grado 1 · coexistencia con recursos para mayores (C7)	Hombres de 65 o más: 27 respuestas	R5, R7
C6	Hecho	Monitor IBSE 2026; INE 2025; SAM (COMPÁS)	Sin relación declarada	Selección voluntaria	R6
C7	Hecho	Localiza Salud, 17 fichas	Conexión activo-tema propuesta, pendiente de declarar	Validación no declarada	R7, R8
C8	Hecho	Informe, tablas 10, 11 y 12	Sin relación declarada	Sin comparadores publicados	R3

A.2 Monitor de bienestar socioemocional Atarfe 2026

Factor (preguntas)	Total	Hombres	Mujeres	13–15	16–24	25–44	45–64	65+
IBSE total	62,2	64,3	61,0	67,6	63,3	59,5	59,5	63,3
Vínculo (deprimido, solo)	72,4	73,8	71,6	73,1	71,6	70,6	73,1	73,5
Situación (feliz, disfrutar)	60,3	62,1	59,3	72,0	63,2	58,0	54,7	56,9
Control (energía, tranquilo)	51,1	54,8	49,0	57,2	54,0	45,5	47,4	54,9
Persona (optimista, bien consigo)	65,0	66,5	64,2	67,9	64,4	63,6	62,8	68,1

811 respuestas válidas (cuestionario completo y ocho preguntas contestadas) de 910 registros. Hombres 294, mujeres 517. Respuestas por edad: 13–15: 145, 16–24: 129, 25–44: 176, 45–64: 216, 65+: 144. Una respuesta con edad 1993 se excluye del desglose por edad.

Pregunta (última semana)	Total	Hombres	Mujeres
Se sintió deprimido/a buena parte del tiempo o casi siempre	16,2 %	12,2 %	18,4 %
Se sintió solo/a buena parte del tiempo o casi siempre	18,4 %	19,4 %	17,8 %
Se sintió feliz en ningún momento o casi ninguno	4,1 %	2,7 %	4,8 %
Disfrutó de la vida en ningún momento o casi ninguno	6,0 %	4,8 %	6,8 %
Rebosante de energía solo en algún momento o en ninguno	46,1 %	42,5 %	48,2 %
Tranquilo/a y relajado/a solo en algún momento o en ninguno	50,7 %	45,2 %	53,8 %
En desacuerdo con «he sido optimista respecto a mi futuro»	14,9 %	12,2 %	16,4 %
En desacuerdo con «me he sentido bien conmigo mismo/a»	12,0 %	10,5 %	12,8 %

A.3 Escala del IBSE: corrección de las fórmulas de REDCap

Cada pregunta se lleva a una escala de 0 a 100 en la que más es mejor. Frecuencia de una emoción negativa (deprimido, solo): (4 − respuesta) / 3 × 100. Frecuencia de una emoción positiva (feliz, disfrutar, energía, tranquilo): (respuesta − 1) / 3 × 100. Acuerdo, donde 1 es «muy de acuerdo» (optimista, bien conmigo mismo): (5 − respuesta) / 4 × 100. Cada factor es la media de sus dos preguntas y el índice total, la media de los cuatro factores.

Factor	Fórmulas de REDCap (rango)	Valor con fórmulas de REDCap	Escala común
Vínculo	0–75	54,3	72,4
Situación	25–100	70,2	60,3
Control	25–100	63,3	51,1
Persona	0–100	65,0	65,0
IBSE total	12,5–93,75	63,2	62,2

La conversión entre ambas escalas es lineal y exacta (Vínculo × 4/3; Situación y Control (x − 25) × 4/3), y se ha aplicado también a la referencia de Granada de la Encuesta Andaluza de Salud 2023: total 78,4; Vínculo 86,1; Situación 79,2; Control 70,2; Persona 78,3. El diccionario de REDCap corregido está en COMPÁS (municipalities/atarfe/redcap).

A.4 Composición de la muestra (SAM) · 15 años o más

Grupo	Padrón 2025 hombres	Muestra hombres	Padrón 2025 mujeres	Muestra mujeres
15–24	7,1 %	14,0 % (105)	6,8 %	14,8 % (111)
25–44	17,5 %	7,4 % (56)	17,9 %	16,0 % (120)
45–64	17,6 %	10,2 % (77)	16,7 %	18,5 % (139)
65 o más	7,3 %	3,6 % (27)	9,0 %	15,6 % (117)

Población de 15 o más años: 17.205 (INE 2025). Muestra teórica de referencia (Cochran, 95 %, ±5 %, p = 0,5, con corrección por población finita): 376; supone selección aleatoria y no es aplicable como margen de error a esta muestra. 752 respuestas válidas de 15 o más años. Celdas sin respuestas: 90 años o más (137 personas en el padrón). Media reponderada por edad y sexo (sensibilidad, sin validar): total 61,2; Vínculo 72,3; Situación 58,0; Control 49,6; Persona 64,8.

A.5 Recursos de Atarfe en Localiza Salud

ID	Recurso	Destinatarios	Temáticas en Localiza
61948	Asociación Artística y Cultural Ciudad Atarfe	Población general	Escuela de salud/formación, Bienestar emocional, Actividad física, Envejecimiento activo, Cultura y ocio
61912	Biblioteca Pública Municipal Marian Pineda de Atarfe	Población general	Escuela de salud/formación, Participación y acción comunitaria, Cultura y ocio
61919	Centro Cívico Almudena Grandes de Atarfe	Población general	Escuela de salud/formación, Bienestar emocional, Personas en riesgo de exclusión, Envejecimiento activo, Participación y acción comunitaria
61585	Centro de Participación Activa de Atarfe	Mayores de 64 años	Bienestar emocional, Actividad física, Alimentación saludable, Envejecimiento activo, Participación y acción comunitaria
61419	Centro de Participación Activa de Atarfe	Otros	Actividad física, Alimentación saludable, Envejecimiento activo, Participación y acción comunitaria, Cultura y ocio
61587	Centro Público de Educación de Personas Adultas Mariana Pineda de Atarfe	Mayores de 64 años, Adultos (30-64 años)	Escuela de salud/formación, Bienestar emocional, Alimentación saludable, Envejecimiento activo, Participación y acción comunitaria
61945	Espacio Joven Atarfe	Adolescentes (12-17 años), Jóvenes (18-29 años)	Bienestar emocional, Participación y acción comunitaria, Cultura y ocio
61427	GIMNASIA MENTAL	Otros	Otros
47600	Grupo de Afrontamiento de la Ansiedad en Atención Primaria (GRAFA)	Mayores de 64 años, Jóvenes (18-29 años), Adultos (30-64 años)	Bienestar emocional
61584	Grupo Socioeducativo (GRUSE - Centro de	Mayores de 64 años, Jóvenes (18-29 años),	Bienestar emocional, Participación y acción

ID	Recurso	Destinatarios	Temáticas en Localiza
	Salud de Atarfe)	Adultos (30-64 años)	comunitaria, Género/identidad
47602	Piscina Cubierta Pública Atarfe (Granada)	Población general	Actividad física, Envejecimiento activo
60152	Punto Vuela Atarfe	Población general	Otros
61944	Radio Ilíberis 101.5 FM de Atrafe	Población general	Participación y acción comunitaria, Cultura y ocio
61425	Taller de Coro del Centro de Participación Activa de Atarfe	Otros	Bienestar emocional, Alimentación saludable, Envejecimiento activo, Participación y acción comunitaria, Cultura y ocio
61429	Taller de Senderismo del Centro de Participación Activa de Atarfe	Otros	Actividad física
63552	Taller de sueño saludable	Mayores de 64 años, Jóvenes (18-29 años), Adultos (30-64 años)	Bienestar emocional, Enfermedades crónicas, Participación y acción comunitaria
61922	Talleres Artísticos Ciudad de Atarfe	Mayores de 64 años, Adolescentes (12-17 años), Jóvenes (18-29 años), Adultos (30-64 años)	Bienestar emocional, Envejecimiento activo, Cultura y ocio

Tabla de Localiza Salud aportada el 05/11/2026; textos literales, incluidas las erratas de origen. No se ha verificado en línea la vigencia de cada ficha.